CONCURSO PÚBLICO
INGÁ (PB): SUPERIOR (TARDE)

NUTRICIONISTA

80 QUESTÕES OBJETIVAS

igeduc

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital;** levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

www.pciconcursos.com.br

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
- Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
- Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
- Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (de 1 a 60)

Julgue os itens a seguir.

01. É sabido que a Vitamina D atua diretamente na absorção de Ca e P, principalmente aumentando ou diminuindo a absorção desse primeiro. Porém essa vitamina, que é na verdade um hormônio, está também envolvida em alterações polimórficas relacionada ao seu receptor (VDR). A sua deficiência pode causar distúrbios muito relevantes à saúde humana, pois ela modula a expressão de genes relacionados ao ciclo proteico que diminuem a proliferação e aumentam a diferenciação celular no cérebro, rins, próstata, mamas, cólon, coração, pâncreas, células mononucleares, linfócitos ativados e pele. Além disso, a forma ativa da vitamina D é conhecida por modular o sistema imune.

02. Estudos longitudinais suportam a hipótese de que a resistência à insulina seria consequência da obesidade. Os ácidos graxos livres fornecidos pelo tecido adiposo na lipólise induzem a resistência à insulina na utilização periférica da glicose, assim como exercem ação inibitória na secreção de insulina pela célula β (lipotoxicidade). O tecido adiposo é responsável por sintetizar e secretar citocinas, que são proteínas moderadoras da resposta inflamatória, produzidas e liberadas por vários tecidos e células, tais como macrófagos, monócitos, adipócitos e células endoteliais. Outra citocina sintetizada é a resistina secretada pelos adipócitos maduros e que poderia ser o elo entre a obesidade e o desenvolvimento da resistência à insulina. Existem evidências que dietas com alto índice glicêmico (AIG) quando consumidas cronicamente afetam o apetite positivamente e o aproveitamento dos macronutrientes, levando ao aumento da adiposidade. Por tudo que foi dito nesse texto e por tudo mais que é visto nesse metabolismo, a constituição da dieta é parte importante da gênese da obesidade, resistência insulínica e o desenvolvimento de DM2.

03. As dietas deverão ser modificadas segundo critérios de importância do estado crítico de um paciente internado em unidade hospitalar. Essas dietas de rotina são baseadas em padrões dietéticos que atendam as necessidades dietéticas recomendadas para cada paciente. Elas são qualitativas e quantitativas, visando a suprir as necessidades nutricionais e manter o equilíbrio do estado nutricional do paciente. As dietas podem apresentar alterações em sua consistência, permitindo seu uso em forma rotineira, contribuindo para a evolução dietética do paciente internado conforme aceitação alimentar ou adequação ao quadro clínico. São consideradas dietas de rotina: Dieta Geral, Dieta Branda, Dieta Pastosa, Dieta Leve e a Dieta Líquida.

04. A Codex Alimentarius Commission, em sua edição de 2019, é um órgão internacional dedicado a estabelecer padrões e diretrizes para garantir a segurança dos alimentos em todo o mundo. Ela aborda a questão da segurança na produção de alimentos através de um conjunto abrangente de princípios e diretrizes. Dentre os Principais Princípios e Diretrizes da Codex Alimentarius Commission de 2019, podemos dizer que o princípio de boas práticas de higiene Alimentar estabelece diretrizes detalhadas para a higiene alimentar que contempla apenas a etapa da cadeia de produção, referente ao nutricionista preocupado com o que chega à mesa do consumidor. Isso inclui critérios para higiene pessoal, manipulação segura de alimentos, controle de pragas, limpeza e saneamento.

05. Segundo o CFN, não compete ao nutricionista atuar em Bancos de Leite Humano (BLH) nos processos relacionados ao planejamento, implantação, coordenação e supervisão de preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento, rotulagem, transporte e distribuição de fórmulas, sendo essa função de exclusividade da equipe médica e de enfermagem. Ao nutricionista compete apenas auxiliar o setor de suprimentos quanto à aquisição de fórmulas infantis, realizando mensalmente o pedido de compra e orientar as puérperas e gestantes sobre a importância da amamentação.

www.pciconcursos.com.br

06. O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) recomenda que qualquer profissional da área de saúde com pós em gestão de UAN, técnico em nutrição ou nutricionista legalmente habilitado possa se candidatar e preencher o cargo de RT deste programa.

07. A diferença entre o resfriamento e o congelamento está nos níveis e graus de temperaturas aos quais os dois processos são submetidos. Embora ambos sejam praticados a temperaturas muito baixas, o resfriamento é utilizado para conservação de alimentos por períodos mais longos, atingindo 0 ºC. Já o congelamento deverá ser utilizado por períodos breves e curtos (dias ou semanas, dependendo do produto) com temperaturas que variam de -10 a -40 ºC.

08. Sobre fórmulas infantis de primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas, podemos afirmar que um produto enquadrado nessa categoria é indicado para crianças entre 1 e 3 anos. Assim, a indicação desse produto somente poderá ser feita para crianças dentro dessa faixa etária.

09. Estudos têm demonstrado que melhorias no saneamento básico estão diretamente ligadas a melhores indicadores de nutrição. Por exemplo, uma pesquisa revelou que crianças que vivem em áreas com baixa cobertura de saneamento tendem a apresentar estatura reduzida devido a um maior risco de infecções intestinais.

10. Tanto o marasmo quanto o kwashiorkor são DPC secundárias, também conhecidas como forma molhada. Ambos comprometem a imunidade mediada por célula, aumentando a susceptibilidade a infecções.

11. A formação da placa de ateroma na parede dos vasos sanguíneos, bem como suas consequências clínicas (infarto do miocárdio e Acidente Vascular Encefálico [AVE]) associam-se intimamente aos determinados fatores de risco cardiovascular, como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidade entre outros. Hoje se sabe que diferentes padrões dietéticos modulam diferentes aspectos do processo aterosclerótico e risco cardiovasculares, como níveis lipídicos no plasma, resistência à insulina e metabolismo glicídico, pressão etc. Logo, o padrão alimentar interfere na chance de eventos ateroscleróticos. As repercussões da ingestão de gordura, no entanto, não se restringem ao metabolismo lipídico; o tipo de gordura ingerida pode influenciar também outros fatores de risco, como a resistência à insulina e a pressão arterial, além da importância dos carboidratos (CH) na gênese da doença cardiovascular que deve ser destacada.

12. Ao elaborar um cardápio, o nutricionista deve ter também uma maior preocupação com a orientação nutricional dos clientes, induzindo-os a optar por uma alimentação equilibrada. Pensando assim, o nutricionista deve elaborar o cardápio de forma a permitir uma escolha saudável com alimentos ricos em fibras e alimentos funcionais, além de conter quantidade adequada de gorduras saturadas.

13. Sobre o aleitamento materno, estaria correto afirmar que as emoções da mãe geram uma conexão com o bebê por meio de estímulos moderados pela liberação de hormônios de origem hipofisária, como: prolactina, ocitocina, ACTH entre outro. Assim, o colostro é liberado após a primeira semana pós-parto, composto por um líquido amarelado, pouco calórico, rico em PTN, e pobre em LIP e CHO, porém rico também em lactobacillus bifidus que fortalecem a microbiota intestinal do bebê protegendo-os contra infecções. Entretanto, após 15 dias, o leite materno já tem mais CHO que o leite de vaca, por exemplo, favorecendo o crescimento da flora benéfica, favorável ao sistema nervoso e aumentando a absorção de Ca, P, Mg e Fe.

14. Com uma alimentação saudável e mantendo-se ativa, a gestante pode ter uma gravidez mais agradável, reduzir o risco de complicações durante a gravidez e o parto e ter um filho mais saudável. Uma meta-análise sugere que a intervenção alimentar durante a gravidez é segura e possui um custo acessível para limitar o ganho excessivo de peso durante a gravidez, melhorar a saúde materno-infantil e reduzir o risco de diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, aborto e alterações metabólicas.

15. Estudos clínicos têm mostrado que um plano alimentar vem apresentando resultados muito bons na redução de dislipidemias, obesidade, hipertensão e diabetes. Ele traz uma proposta quantitativa, em função das porções de alimentos, que incentiva o consumo de frutas, verduras, laticínios desnatados, restringe sódio, carnes ricas em gordura saturada, colesterol e doces e incentiva o consumo de peixes, frango e grãos. Esse plano nutricional surgiu nos EUA para tratar hipertensão e recebeu o nome de DASH.

16. A dieta enteral, ou nutrição enteral (NE), é um tipo de alimentação que permite administrar todos os nutrientes, ou parte deles, através do sistema digestivo. Um nutricionista deve saber que a NE é indicada nos seguintes casos: trato digestivo total ou parcialmente funcional; diarreia intratável (crônica); obstrução intestinal mecânica ou pseudo-obstrução; previsão de jejum superior a 3 dias em pacientes críticos.

17. Para atuar em UAN´s, os nutricionistas devem ter conhecimento sobre técnicas dietéticas, dessa forma saberão que alguns alimentos como PTN´s e algumas vitaminas podem perder volume sem alteração da sua estrutura devido pelo excesso de calor, como acontece na reação de Maillard, onde não há o comprometimento dos aminoácidos.

18. Um estudo revelou que patógenos podem persistir em superfícies por períodos prolongados, contribuindo para a disseminação de infecções. A eficácia dos desinfetantes é essencial para evitar a propagação de HAIs, visto que superfícies contaminadas podem servir como fontes de infecção.

19. A desnutrição pode ser definida como uma condição clínica decorrente de uma deficiência ou excesso, relativo ou absoluto, de um ou mais nutrientes essenciais. Baseado nessa definição, é possível um nutricionista receber um paciente infantil que sofra de obesidade e se encontre em estado desnutrido.

www.pciconcursos.com.br

20. O sistema HACCP é uma ferramenta valiosa criada para melhorar a segurança alimentar e reduzir os problemas relacionados com a qualidade e a segurança dos alimentos no comércio, sem a necessidade da implementação de outros sistemas, e seguindo os Princípios Gerais de Higiene Alimentar do Codex, aplicados conforme apropriado em toda a cadeia alimentar.

21. Em geral, amostras de alimentos devem ser transportadas e estocadas da mesma maneira como o produto é normalmente transportado e estocado na sua comercialização. Como exemplo, podemos citar os alimentos desidratados, secos ou concentrados que são estáveis microbiologicamente, podendo ser transportados e estocados à temperatura ambiente, devendo, no entanto, ser protegidos contra a umidade.

22. A nutrição de lactentes e crianças de baixo peso é uma questão multifacetada. Tanto a amamentação quanto a fórmula infantil fortificada desempenham papéis essenciais na promoção do crescimento saudável. No entanto, considerar fatores socioeconômicos é fundamental para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma nutrição adequada, independentemente de suas circunstâncias.

23. Os alimentos prejudicam a absorção de muitos antibióticos. Em contrapartida, os fármacos podem afetar a nutrição corporal. Alimentos podem alterar o metabolismo dos fármacos; p. ex., dietas hiperprotéica podem acelerar o metabolismo de determinados fármacos pela estimulação do citocromo P-450.

24. Os profissionais de serviços de alimentação devem adotar certos procedimentos a fim de garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Por exemplo, o estabelecimento deve dispor de recipientes identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade suficientes para conter os resíduos. Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos e o armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.

25. O regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, vigente na RDC 216, expõe orientações sanitárias para algumas das seguintes atividades comerciais: cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Excete, lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, os bancos de leite humano, as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde e os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.

26. Em consonância com a recomendação da OMS, o Brasil, com todo seu pioneirismo, buscou consolidar sua agenda de forma consistente para discutir e implementar os temas sobre a segurança alimentar. No escopo das ações do governo brasileiro para a promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira – Promovendo a Alimentação Saudável, com as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. Junto com o PAPB, vieram também o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, entre outras, que ajudaram a expandir para a criação de outros instrumentos como o NASF, PAAS entre outras ações de atenção básica a saúde.

27. É a partir de uma boa estruturação do planejamento de um cardápio que se torna viável a otimização de recursos humanos, controle de custos, compras de insumos, matéria-prima e gestão de estoque com maior foco na qualidade do serviço prestado a clientela.

28. A atuação do nutricionista no Nasf tem como único foco a saúde dos indivíduos que compõem a comunidade. Os determinantes sociais do processo saúde–doença devem ser objeto de especial atenção, condicionando as práticas em saúde e o direcionamento do processo de trabalho.

29. Em situações de emergência, como a pandemia de COVID-19, a legislação sanitária pode ser invocada para ordenar medidas de isolamento social e restrições de movimento, mudando para conter a propagação do vírus. Esse contexto de pandemia revelou desafios nesse equilíbrio, pois medidas de vigilância podem afetar as liberdades individuais e gerar preocupações sobre privacidade e discriminação. Portanto, a legislação sanitária deve ser redigida com precisão e ser transparente quanto a seus critérios.

30. A avaliação nutricional (AN) é uma ferramenta muito importante na compreensão do estado nutricional do indivíduo ou mesmo de uma população. Por meio da AN, o nutricionista obtém e analisa indicadores diretos que são relevantes para a sua atuação profissional como, por exemplo, a taxa de consumo alimentar dos pacientes.

31. Refrigerantes engarrafados e comercializados em temperatura ambiente podem ser transportados e estocados à temperatura ambiente, devendo apenas ser protegidos contra exposição a temperaturas superiores a 40 ºC.

32. Em se tratando de DRC, a conduta nutricional para aporte de PTN em pacientes dos estágios 4 e 5 não dialíticos deverá ser de um mínimo de 0,8 g/Kg/dia em adultos, acompanhado de adequada orientação nutricional, devendo-se evitar ingestão maior do que 1,3g/kg/dia nos pacientes que necessitarem, por outra indicação, ingesta acima de 0,8 g/kg/dia.

33. Em humanos, o ácido úrico é o produto final das purinas. Os produtos das purinas resultantes da ação da purina-nucleotídeo-fosforilase, guanina e hipoxantina são convertidos em ácido úrico por intermédio do tocoferol em reações catalisadas pela enzima guanase e tocoferol oxidase.

www.pciconcursos.com.br

34. Dentro de uma UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição), é verdade dizer que o cardápio é a base do processo de trabalho. Entretanto, como não se trata de uma prescrição clínica, o cardápio não precisa considerar alguns aspectos, tais como as necessidades nutricionais e os hábitos alimentares da clientela.

35. A segurança na produção de alimentos é um desafio crucial devido à necessidade de garantir que os alimentos sejam produzidos, processados e distribuídos de maneira a minimizar riscos para a saúde humana. Entre os principais desafios estão a contaminação microbiológica, a presença de resíduos de pesticidas e produtos químicos, bem como a adulteração intencional.

36. Segundo a OMS, as anemias podem ter causas diversas que não apenas por ferro, podendo ocorrer, por exemplo, por deficiência de outros nutrientes como zinco, vitamina B12 e proteínas. A anemia causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais (estima-se que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro).

37. A seleção cuidadosa de produtos químicos, os métodos de aplicação precisos, a validação constante da eficácia e uma gestão sólida da qualidade são elementos cruciais nesse processo. A seleção de produtos químicos envolve a escolha de desinfetantes, detergentes e saneantes não exclusivos e adequados para um tipo de superfície e agente patogênico específico a ser eliminado.

38. A diminuição da taxa metabólica é uma resposta metabólica inicial à desnutrição energético-proteica. Para suprir energia, o organismo vai primeiro quebrar o tecido adiposo. Contudo, depois que esse tecido é depletado, o corpo pode se utilizar das proteínas para produzir energia, o que resulta em balanço nitrogenado negativo. Órgãos viscerais e tecidos musculares também são quebrados, com consequente diminuição do peso. A perda ponderal dos órgãos é maior no fígado e no intestino, intermediária no coração e nos rins e menor no sistema nervoso central.

39. Um nutricionista, ao receber seu paciente ou atuar com educação nutricional, deve saber passar de maneira generalista os principais cuidados acerca da prevenção e tratamento de doenças. De modo geral, deve-se recomendar uma dieta unicamente qualitativa, proporcionando alimentos mais energéticos. Essa ação tem como objetivo elevar o aporte calórico dentro de um balanço energético normativo entre os macro e micronutrientes a serem ofertados, principalmente em situações de patologia, nas quais o nutricionista deverá adotar uma dietoterapia hipercalórica para melhorar a reposta anti-inflamatória pelo gasto energético.

40. Em alguns pacientes portadores de diabetes, principalmente do tipo 2 (DM 2), as proteínas podem ser convertidas em glicose muito facilmente, gerando efeitos negativos sobre o índice glicêmico, mesmo quando esse consumo é moderado. Mesmo em pessoas com o diabetes controlado, tanto do tipo 1 quanto do 2, com adequado consumo alimentar, é muito comum esses efeitos adversos apresentados relacionados ao consumo de proteínas.

41. A vitamina B12 é encontrada no sangue ligada a três transcobalaminas (TCI, TCII e TCIII) que são transportadoras dessa molécula. Sabe-se, no entanto, que TCI e TCIII transportam de 2% a 4% da B12 em nosso corpo e a TCII apenas 6 a 8%.

42. Analisando que as recomendações de ingestão dietética (DRI, The Dietary Reference Intakes) são valores de referência de nutrientes, desenvolvidos pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM), e servem como um guia para a boa nutrição, fornecendo a base científica para o desenvolvimento de guias de alimentação. É de conhecimento dos nutricionistas que a UL é usada como uma meta de ingestão do nutriente para os indivíduos, quando não é possível determinar a RDA.

43. O decreto acerca de normas básicas sobre alimento de 1969 considera que alimento in natura é todo alimento derivado de matéria-prima vegetal que tenha sido submetido a até 3 (três) fases de processamento industrial, cujas características básicas e níveis de nutrientes podem ter sido alterados por acréscimo de conservantes ou corantes.

44. O nutricionista tem como objetivo prestar serviço ao PAT, buscando enquadrar as refeições servidas aos trabalhadores pela empresa solicitante às normas de segurança alimentar e nutricional da legislação vigente, além de executar, fiscalizar, formalizar e prestar contas das ações desenvolvidas no Programa, estando o profissional assumindo a condição de responsável técnico.

45. O Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Atenção Básica em Saúde e o Pacto pela Vida, que constituem marcos legais que expressam as intenções e os compromissos dos gestores com a responsabilidade sanitária. Esses instrumentos determinam explicitamente as ações de alimentação e nutrição nos programas e ações da Atenção Primária em Saúde, além de tornar obrigatória a presença de um Nutricionista em cada unidade de serviço público no Brasil.

46. O nutricionista tem que estar atualizado às diretrizes do CFN - Conselho Federal de Nutricionistas. Dentro dessa perspectiva, o CFN criou um grupo informal e obrigatoriamente constituído por pelo menos um profissional de cada uma das seguintes categorias: médico e um nutricionista. Nesse contexto, são especificidades técnicas do nutricionista que compõe esse grupo: registrar em prontuário dos clientes / pacientes / usuários a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos e estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço, obedecendo à legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) específica para o setor.

47. Para um paciente com Diabetes Mellitus, a dietoterapia deve fornecer calorias adequadas para a conservação da eutrofia e a plena atividade, mantendo o equilíbrio entre a ingestão de alimentos e a insulina disponível, numa estratégia nutricional equilibrada e de acordo com as necessidades individuais.

www.pciconcursos.com.br

48. É sabido por nutricionistas e engenheiros de alimentos que existem várias técnicas de conservação de alimentos. Dentre as principais podemos citar: apertização pelo calor, sublimação de água livre e desidratação por frio, pelo uso do açúcar por adição de soluto, irradiação de alimentos por radiação gama entre outros.

49. Um estudo de meta-análise apontou que a melhoria do saneamento está associada a uma redução significativa da incidência de doenças infecciosas. Embora o estudo tenha mostrado uma pequena melhora na absorção de nutrientes, não houve melhoras do estado nutricional das crianças.

50. Embora seja difícil definir a nutrição ideal, é consenso que um bom aporte proteico e um déficit calórico seriam suficientes para que uma gestação se desenvolvesse de forma apropriada. Todavia, os conceitos atuais valorizam a importância da ingestão elevada de micronutrientes e diminuída em macronutrientes, evitando obesidade, por exemplo, na saúde presente e futura dos seres humanos.

51. Na prática do nutricionista, não importam muito os dados epidemiológicos. Seja em uma prática clínica, hospitalar, esportiva, não importa. Com o entendimento da epidemiologia das doenças, é possível propor mudanças políticas, criar ações sociais com objetivos específicos em doenças que atingem mais determinada região, idade, condição econômica, nível de escolaridade ou sexo e, entretanto, não seria possível gerar soluções para combater esses males.

52. O estudo saúde-doença da epidemiologia propõe analisar e distribuir os determinantes das doenças, dos danos e dos eventos relacionados à saúde. No entanto, não é de sua competência sugerir ou propor medidas específicas de prevenção e controle de doenças, de danos e de eventos relacionados à saúde.

53. O padrão alimentar não representa um fator específico que pode modular a imunocompetência. Logo, a investigação de deficiências nutricionais, bem como a investigação da ingestão de suplementos nutricionais não serão fatores que interferem na avaliação da resposta imune de um indivíduo. Esse padrão alimentar pode interferir sem grandes problemas na mucosa intestinal, que no intestino não atua como responsável pela regulação do sistema imunológico humano. Logo os alimentos ingeridos não afetam diretamente o aumento de doenças infeciosas, bem como a dificuldade em tratá-las e do indivíduo se recuperar e não ter recaídas.

54. Criado pela Constituição Federal de 1988, o SUS é um sistema público que busca assegurar o direito à saúde de todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica. Decisões judiciais que ordenam ações específicas podem levar a um desequilíbrio na distribuição de recursos, favorecendo indivíduos em detrimento da coletividade. Além disso, a alocação de recursos limitados para atender demandas judiciais pode comprometer a capacidade do SUS de fornecer serviços essenciais para a população mais ampla. A tomada de decisão judiciária deve considerar tanto as necessidades dos indivíduos quanto a responsabilidade de proteger o sistema de saúde como um todo.

55. Seguindo as orientações da portaria do NASF, referendamos que as ações de alimentação e nutrição integrem o compromisso do setor saúde com relação aos componentes do SISAN, com vista ao Direito Humano à Alimentação Adequada. Nesse sentido, podemos afirmar que é papel do nutricionista na atenção primária à saúde nutricional realizar o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população com a identificação de áreas geográficas e segmentos de maior risco aos agravos nutricionais, grupos em situação de insegurança alimentar e nutricional com base no sistema de vigilância alimentar e nutricional.

56. Os estágios de desenvolvimento cognitivo são sequenciais. Dessa forma, a criança deve atravessar cada estágio segundo uma sequência regular. Se a criança não for estimulada ou motivada no devido momento, ela não conseguirá superar o atraso do seu desenvolvimento, pois o desenvolvimento infantil se dá à medida que a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, de acordo com os meios onde vive e os estímulos deles recebido.

57. Em sua rotina clínica, os nutricionistas irão se deparar frequentemente com pacientes acima do peso ou com distúrbios metabólicos, entre eles a hipertensão. Desse modo, é básico saber lidar com cada paciente baseado em atualizações de sociedades e associações de cardiologia, hipertensão e diabetes do Brasil e do mundo. Dito isso, é verdade informar que os principais cuidados a serem tomados pelo nutricionista com pacientes hipertensos dizem respeito à mudança dos hábitos, introduzindo um padrão alimentar mais saudável, rico em frutas, hortaliças, cereais integrais e laticínios magros, tais como a dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) e mediterrânea.

58. Quando as maçãs da sobremesa chegam com casca, elas têm 500g de peso líquido. Após serem descascadas, tem 400g de peso bruto. Dessa forma, peso bruto é o peso do alimento com ossos, sementes, gordura, pele etc., enquanto o peso líquido é o peso do alimento sem aparas, permanecendo apenas a parte comestível.

59. A VAN, como componente da vigilância em saúde e potencializada nas ações de Atenção Básica, tem o papel fundamental de apoiar profissionais de saúde na avaliação da atenção nutricional, permitindo que sejam definidas prioridades com base no acompanhamento de indicadores de alimentação e nutrição da população assistida. Porém é importante ressaltar que não é parte de sua responsabilidade atuar como apoio ou orientação para gestores de saúde em processos de organização e avaliação da atenção nutricional.

60. Você recebe em seu consultório um paciente com altos índices de triglicerídeos. As melhores indicações clínicas não medicamentosas e competentes ao nutricionista para baixar os índices de triglicerídeos seriam: substituir gordura poli-insaturada, por mono e saturada, diminuir a gordura trans da dieta para melhorar e controlar a hipercolesterolemia, aumentando a oferta de carboidrato simples, evitando a desnutrição por balanço energético negativo desse paciente.

www.pciconcursos.com.br

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens que se seguem.

61. Na Língua Portuguesa, atribui-se o nome de "radical" ao núcleo da palavra, no qual reside seu significado.

62. A vogal temática, na Língua Portuguesa, é acrescida ao radical para formar o tema da palavra.

63. No processo de derivação prefixal, na Língua Portuguesa, a palavra primitiva recebe um sufixo precedido de uma vogal atômica. Por exemplo: reconhecer, descrença e injusto.

64. Na palavra PEZINHO, o sufixo "pe-" é acrescido do radical "-inho", mas, para facilitar a pronúncia, a consoante de ligação "-z-" é utilizada.

65. Considere um triângulo ABC onde AB = AC. Sejam também os pontos D e E pertencentes aos lados AB e AC, respectivamente, onde AB = 4DB e AC = 4AE. Se a área do quadrilátero BCED é 52 cm², então a área do triângulo ADE é menor que 10 cm².

66. Durante uma festa da empresa, a média de tempo de experiência entre os 25 funcionários presentes é de 4 anos e 3 meses. O número total de funcionários com 4 anos e 9 meses de experiência que precisa participar da festa para elevar a média de tempo de experiência de todos os presentes para 4 anos e 4 meses é superior a 10.

67. O valor máximo que "a" pode assumir para que as equações $a^2 - bc - 8a + 7 = 0$ e $b^2 + c^2 + bc - 6a + 6 = 0$ sejam satisfeitas, considerando os números reais "b" e "c", é 9.

68. Em "Amanhã vou à cidade", tem-se um uso do presente do indicativo para retratar uma ação futura.

69. O hífen nos termos "semi-hospitalar", "proto-história" e "anti-horário" se justifica pela junção de prefixo ou falso prefixo com palavra iniciada por "h".

70. A vogal "i" deve ser empregada na sílaba final dos verbos terminados em -UAR e -UIR: diminui, habitui, influi e pontui.

71. Na sentença "Mais de um estudante faltaram", o verbo deve ficar no plural, enquanto em "Menos de dois alunos veio", o verbo fica no singular porque precisa concordar com o número representado (menos de dois = 1).

72. Com o novo acordo ortográfico, o acento diferencial de "PARA" (verbo), em oposição a "PARA" (preposição), deixou de existir, ficando a cargo do contexto permitir a correta compreensão.

73. Os vocábulos "você", "saúde", "prática" e "fóssil" são acentuados por serem, respectivamente, oxítona, paroxítona, proparoxítona e novamente paroxítona.

74. A palavra "rubrica" costuma ser erroneamente pronunciada e grafada como uma proparoxítona (RÚbrica), mas na verdade ela se trata de uma paroxítona, não tendo, portanto, acento gráfico e devendo ser pronunciada como "ruBRIca".

75. As reclamações apresentadas no protocolo da Câmara Municipal de Ingá – PB, em relação às contas do município, deverão ser apresentadas em três vias, registradas em cartório (Lei Orgânica de Ingá – PB).

76. Havendo vacância dos cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Ingá – PB, o Presidente da Câmara poderá recusar assumir a prefeitura, devendo realizar eleições diretas no prazo de 90 dias, independente do momento do mandato (Lei Orgânica de Ingá – PB).

77. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ingá – PB, os crimes de responsabilidade serão definidos em Lei Especial, devendo obedecer a Lei Federal que trate de normas de processo e julgamento.

78. A Lei Orgânica do Município de Ingá – PB poderá ser emendada mediante proposta individual de qualquer um dos membros da Câmara Municipal.

79. O Estado da Paraíba poderá intervir no Município de Ingá caso não seja aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (Lei Orgânica de Ingá – PB).

80. O número de Vereadores do Município de Ingá – PB, para cada legislatura, será atualizado de acordo com a população existente, apurada até o último dia do mês de março do ano eleitoral, e atualizado em Lei Estadual.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br